AULA CLÍNICA — SEMIOLOGÍA I

Sistema digestivo: lo que pregunta el profe

La unidad que el profesor define como una de las más preguntadas en parciales y finales: motivos de consulta, examen físico, síndromes del tubo digestivo, hígado, páncreas, vías biliares y emergencias.

- Vómitos, disfagia y dispepsia

Versión del 8 de noviembre de 2026 · 1 capítulo publicado · Material original elaborado a partir de las clases del Dr. Ortega y su libro de Clínica Médica I.

CAPÍTULO 1

Vómitos, disfagia y dispepsia

Digestivo es **una de las unidades más preguntadas** en parciales y finales. De este tema se toman sobre todo **los tipos de vómito**, **el cuadro hematemesis vs hemoptisis**, **la tríada de Mallory-Weiss** y **la acalasia**.

> En la grabación se escucha «la hematemesis tiene pH alcalino», pero el cuadro del libro del profe (p. 75) dice que la **alcalina es la hemoptisis**. Respondé con el libro.

Lo que pregunta el profe

1. **P0** ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre hematemesis y hemoptisis? — «...pregunta de parcial... ese cuadrito tienen que sabérselo»
2. **P0** Disfagia intermitente y lentamente progresiva para sólidos y líquidos, con regurgitación: ¿qué sospecha y por qué? — «...lo que siempre suelen preguntar»
3. **P1** ¿Qué es el vómito? ¿Qué es la náusea? ¿Cómo se clasifican los vómitos? — «...la clasificación... les pueden preguntar»
4. **P1** ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Mencione su tríada. — «...hay una tríada característica: hematemesis, vómito y alcoholismo»
5. **P1** ¿Cuáles son las complicaciones del vómito y por qué se producen? — Complicaciones del vómito: se preguntan en la cátedra
6. **P1** Diferencie disfagia orofaríngea de esofágica. — "Estas características no pueden olvidarse"
7. **P1** Defina dispepsia y mencione sus signos de alarma. — "Siempre digo las dos D y la P"

Sabete esto

Hematemesis vs hemoptisis P0 · Lo toma

Sale con	el **vómito** (náuseas) · la **tos**
Aspecto	**borra de café** · **roja rutilante, espumosa**
Reacción	**ácida** · **alcalina**
Después	**melena** · sin melena

Vómito P1 · Muy remarcado

Qué es	Expulsión **violenta** por la boca del contenido gastroduodenal. Sin esfuerzo = **regurgitación**
Contenido	Alimenticio → **esófago** · ácido → **estómago** · bilioso → **duodeno** · hemático · fecaloide → **obstrucción baja**
Horario	Matinal: **embarazo, alcohol, HTE** · varias horas: **píloro** · en chorro sin náuseas: **HTE**

Complicaciones del vómito P1 · Muy remarcado

Se pierden HCl, agua y K^+	**Alcalosis metabólica**, **hipopotasemia**, **deshidratación**
Aspiración	Neumonitis química → **neumonía aspirativa**
Tríada de Mallory-Weiss	**Alcoholismo** → **vómitos** → **hematemesis** (desgarro de la mucosa)
Boerhaave	Rotura de **todo el espesor**: emergencia

Disfagia P0 · Lo toma

Acalasia	**Sólidos y líquidos, lenta y progresiva, regurgitación** · pico de pájaro
Alta vs baja	Transferencia (tos, ahogo, nariz) · transporte (retroesternal)
Muro vs motor	Mecánica: **solo sólidos** · motora: **sólidos y líquidos**

Dispepsia P2 · Complementario

Roma	Plenitud · saciedad precoz · dolor · ardor epigástrico (3 meses, inicio ≥ 6)
Regla del profe	Las **2 D y la P**: dolor, distensión, pirosis
Alarma	**VIDA que PESA → VEDA**

Cuadros

Hematemesis vs hemoptisis P0 · Lo toma

«...pregunta de parcial... ese cuadrito tienen que sabérselo»

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 08:08 | Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 08:24

	HEMATEMESIS	HEMOPTISIS
Sale con	El **vómito** (precedida de náuseas)	La **tos** (cosquilleo laríngeo)
Aspecto	Oscura, **borra de café**, coágulos, restos de comida	**Roja rutilante, espumosa**
Reacción	**Ácida**	**Alcalina**
Después	**Melena**	Esputo hemoptoico, sin melena
Antecedentes	Digestivos	Respiratorios

¿Por qué? El ácido del estómago transforma la hemoglobina en **hematina ácida**: por eso es oscura. La sangre de la vía aérea viene mezclada con **aire**: por eso es espumosa. La sangre que pasa al intestino se digiere y sale como **melena** (libro, p. 75).

> En la grabación se escucha «la hematemesis tiene pH alcalino»; el cuadro del libro asigna la reacción **alcalina a la hemoptisis**. Respondé con el libro.

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 08:08 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 75

Tipos de vómito según el contenido P1 · Muy remarcado

«...la clasificación por tipo de vómito les pueden preguntar» Clase MC Digestivo · parte 2 · min 15:51

TIPO	ASPECTO	DE DÓNDE VIENE / PENSAR EN
Alimenticio	Comida casi entera, sin ácido	**Esófago**
Parcialmente digerido	Ácido, con restos	**Estómago**: gastroparesia, obstrucción pilórica
Bilioso	Amarillo verdoso, **amargo**	**Duodeno** (refluye bilis). El síndrome pilórico **no** da biliosos
Hemático	**Rojo** = sangrado activo · **borra de café** = sangre digerida	Sangrado alto: primero descartar **úlcera**; várices, Mallory-Weiss, cáncer
Fecaloide	Marrón, olor fecal	**Obstrucción intestinal baja** · fístula gastrocólica

¿Por qué? En una obstrucción, el contenido no avanza y refluye desde el nivel obstruido: los vómitos son **alimentarios** → **biliosos** → **fecaloides** a medida que el obstáculo está más abajo (libro, p. 377).

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 15:51 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 17:13 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 18:33 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 377

Horario del vómito

P1 · Muy remarcado

CUÁNDO	PENSAR EN
Matinal, en ayunas	**Embarazo**, **alcohol** la noche anterior, **hipertensión endocraneana**
≈ 1 hora después de comer	Estómago
Varias horas después	**Píloro**: alimentos retenidos
En chorro, sin náuseas	**Hipertensión endocraneana** (con cefalea)
Calma el dolor al vomitar	Úlcera

¿Por qué? En el **síndrome pilórico** el estómago no se vacía: el vómito aparece **4 a 6 horas después de comer**, con alimentos retenidos (libro, p. 375).

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 19:13 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 21:54 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 22:35 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 375

Complicaciones del vómito P1 · Muy remarcado

Las complicaciones del vómito se preguntan en la cátedra Clase MC Digestivo · parte 2 · min 23:15

COMPLICACIÓN	POR QUÉ
Alcalosis metabólica	Se pierde **ácido clorhídrico**; en el vómito gástrico predomina la pérdida de cloro
Hipopotasemia	Se pierde **potasio**
Deshidratación	Se pierde **agua**: taquicardia, hipotensión
Neumonía aspirativa	Aspira el vómito → **neumonitis química**
Mallory-Weiss	Desgarro de la **mucosa** por el esfuerzo → hematemesis
Boerhaave	Rotura de **todo el espesor** → mediastino · emergencia

¿Por qué? Vómitos repetidos → pérdida de agua, cloro (HCl) y potasio → **deshidratación, hipopotasemia y alcalosis**. Si se pierden sobre todo líquidos intestinales (alcalinos), puede haber acidosis (libro, p. 377).

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 23:15 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 23:55 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 24:37 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 377

Mallory-Weiss vs Boerhaave P1 · Muy remarcado

«...hay una tríada característica: hematemesis, vómito y alcoholismo»

Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 16:48

	MALLORY-WEISS	BOERHAAVE
Qué se rompe	Desgarro **lineal de la mucosa** de la unión esofagogástrica	Rotura de **todo el espesor** del esófago
Cómo se presenta	**Hematemesis** después de vómitos	Paso al **mediastino**: emergencia
Tríada (y cronología)	**Alcoholismo → vómitos → hematemesis**	—

FUENTE Clase Hemorragias digestivas · parte 1 · min 16:48 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 24:37 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 390

Disfagia: orofaríngea vs esofágica P1 · Muy remarcado

«Estas características no pueden olvidarse» Clase MC Digestivo · parte 1 · min 03:42

	OROFARÍNGEA	ESOFÁGICA
Otro nombre	Alta · **de transferencia**	Baja · **de transporte**
Qué refiere	No puede **iniciar** la deglución; señala la garganta	Traga bien y **después** se atasca detrás del esternón
Síntomas	**Tos, ahogo, regurgitación nasal**, disfonía	Atascamiento **retroesternal**
Más difícil con	**Líquidos**	Depende: mecánica o motora
Causa n.º 1	**ACV** (≈ 75 % neuromusculares)	**Estenosis péptica** (mecánica)

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 03:00 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 03:42 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 05:47

Disfagia esofágica: mecánica vs motora P0 · Lo toma

Acalasia: «...lo que siempre suelen preguntar» Clase MC Digestivo · parte 1 · min 21:30

	MECÁNICA (MURO)	MOTORA (MOTOR)
Alimentos	**Solo sólidos**	**Sólidos y líquidos**
Evolución	Continua y **progresiva**	**Intermitente**
Causas	Estenosis péptica (n.º 1), cáncer	**Acalasia**, espasmo difuso, esclerodermia
Esofagograma	**Manzana mordida** (cáncer → endoscopía con biopsia)	**Pico de pájaro** (acalasia; manometría confirma)

¿Por qué? Acalasia: se altera el **plexo mientérico de Auerbach** (idiopática o **Chagas**) → **aperistalsis** y el esfínter esofágico inferior **no se relaja** → el esófago se dilata (dolicomegaesófago): disfagia para sólidos y líquidos, regurgitación, dolor torácico (libro, p. 369).

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 12:48 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 13:28 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 21:30 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 24:50

Clase MC Digestivo · parte 1 · min 25:31 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 368 | Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 369

Dispepsia P2 · Complementario

«Siempre digo las dos D y la P» Clase MC Digestivo · parte 2 · min 07:34

QUÉ	DATO
Dónde	«Boca del estómago»: siempre **del ombligo para arriba**
Roma (4 síntomas)	Plenitud posprandial · saciedad precoz · dolor epigástrico · ardor epigástrico
Tiempo	Últimos **3 meses**, con inicio **≥ 6 meses** antes; sin lesión estructural
Clínica	Las **2 D y la P**: **D**olor · **D**istensión · **P**irosis
Tipos	Funcional **60 %** · orgánica 40 % (**úlcera péptica** n.º 1)
Alarma → VEDA	Vómitos persistentes, ictericia, disfagia progresiva, anemia, pérdida de peso, edad > 55, sangrado, AINEs o antecedentes de cáncer
Sin alarma (joven)	Test no invasivo de *H. pylori*: + → tratar · – → IBP · sin respuesta → VEDA

> Mnemotecnia propia para la alarma: **una VIDA que PESA lleva a la VEDA** (Vómitos, Ictericia, Disfagia, Anemia · Pérdida de peso, Edad, Sangrado, AINEs).

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 27:32 | Clase MC Digestivo · parte 1 · min 30:52 | Clase MC Digestivo · parte 1 · min 34:10 | Clase MC Digestivo · parte 2 · min 07:34 | Clase MC Digestivo · parte 2 · min 08:14 | Clase MC Digestivo · parte 2 · min 10:54

Desarrollos modelo

1. PO · Lo toma ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre hematemesis y hemoptisis?

	HEMATEMESIS	HEMOPTISIS
Sale con	El **vómito** (precedida de náuseas)	La **tos** (cosquilleo laríngeo)
Aspecto	Oscura, **borra de café**, coágulos, restos alimentarios	**Roja rutilante, espumosa**
Reacción	Ácida	**Alcalina**
Después	**Melena**	Esputo hemoptoico, sin melena
Antecedentes	Digestivos	Respiratorios

Porqué: el ácido gástrico convierte la hemoglobina en hematina ácida (oscura); la sangre de la vía aérea viene con aire (espuma).

2. PO · Lo toma Disfagia intermitente y lentamente progresiva para sólidos y líquidos, con regurgitación: ¿qué sospecha y por qué?

Acalasia (disfagia esofágica **motora**). Sólidos y líquidos porque falla el peristaltismo, no hay un obstáculo.

Porqué: alteración del plexo de Auerbach (idiopática o Chagas) → aperistalsis y EEI que no se relaja → dolicomegaesófago. **Esofagograma:** pico de pájaro; **manometría** confirma.

3. P1 · Muy remarcado ¿Qué es el vómito? ¿Qué es la náusea? ¿Cómo se clasifican los vómitos?

Vómito: expulsión activa por la boca del contenido gastroduodenal. **Náusea:** deseo de vomitar. No confundir con la **regurgitación** (sin esfuerzo).

- **Por contenido:** alimenticio (esófago) · parcialmente digerido/ácido (estómago) · bilioso (pancreático, hepático, biliar) · hemático (rojo = activo; borra de café = digerido) · fecaloide (obstrucción baja).
- **Por horario:** matinal en ayunas → embarazo, alcohol, HTE · 1 h después de comer → estómago · varias horas → píloro · nocturno → orgánico.
- En **chorro sin náuseas** → HTE.

4. P1 · Muy remarcado ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Mencione su tríada.

Desgarro **lineal de la mucosa de la unión esofagogástrica** por vómitos o arcadas intensas. **Tríada (y cronología): alcoholismo → vómitos → hematemesis.**

No confundir con **Boerhaave**: rotura de **todo el espesor** del esófago, con paso al mediastino.

5. P1 · Muy remarcado ¿Cuáles son las complicaciones del vómito y por qué se producen?

- **Hipopotasemia y alcalosis metabólica:** se pierden potasio y ácido clorhídrico (predomina la pérdida de cloro).
- **Deshidratación:** taquicardia, hipotensión.
- **Neumonitis química → neumonía aspirativa** si aspira el vómito.
- **Mallory-Weiss** (desgarro mucoso, hematemesis) y **Boerhaave** (rotura transmural).

6. P1 · Muy remarcado Diferencie disfagia orofaríngea de esofágica.

Orofaríngea (alta, de transferencia): no puede iniciar la deglución, señala la garganta, regurgita por boca o nariz, tos y ahogo; más con líquidos; ACV n.º 1.

Esofágica (baja, de transporte): traga y luego se traba detrás del esternón. **Mecánica:** solo sólidos, progresiva (estenosis péptica n.º 1). **Motora:** sólidos y líquidos, intermitente.

7. P1 · Muy remarcado Defina dispepsia y mencione sus signos de alarma.

Dolor o malestar del **abdomen superior** con plenitud posprandial, saciedad precoz, dolor o ardor epigástrico (Roma: 3 meses, inicio ≥ 6 meses). Funcional 60 %, orgánica 40 % (úlcera n.º 1). Clínica: **dolor, distensión, pirosis**.

Alarma (→ endoscopía): > 55 años, pérdida de peso, hematemesis, vómitos persistentes, disfagia progresiva, ictericia, anemia, AINEs, antecedentes de cáncer.

Memoria activa

Hematemesis vs hemoptisis

	HEMATEMESIS	HEMOPTISIS
Sale con	Vómito	Tos
Color	Oscura / borra de café	Roja, espumosa
pH	Ácido	Alcalino
Después	Melena	—

Mnemotecnia: Hemat-EMESIS = vómito · Hemop-TISIS = pulmón. — El nombre te dice de dónde viene: emesis es vómito; tisis remite al pulmón.

Tríada de Mallory-Weiss

- **A**lcoholismo
- **V**ómitos
- **H**ematemesis
- Lesión: desgarro lineal de la mucosa esofagogástrica

Mnemotecnia: A-V-H: Alcohol → Vómito → Hemorragia. — En ese orden ocurren los hechos.

Tipos y horario del vómito

- Contenido: **Entero** → **Ácido** → **Amargo** → **Fecal** (esófago → estómago → bilis → intestino bajo).
- Rojo = ahora; borra de café = antes.
- Matinal: **E**mbarazo, **A**lcohol, **H**TE · varias horas: píloro · chorro sin náuseas: HTE.

Mnemotecnia: "¡EAH, qué mañana!" — Vómito matinal = Embarazo, Alcohol, HTE.

Disfagia: dónde y con qué

- **Alta (transferencia):** se atraganta — tos, ahogo, nariz.
- **Baja (transporte):** se atasca detrás del esternón.
- **Solo sólidos** = mecánica · **sólidos + líquidos** = motora (acalasia).

Mnemotecnia: Arriba se ATRAGANTA, abajo se ATASCA · MURO o MOTOR. — Un muro deja pasar el agua pero no la piedra; un motor roto no empuja nada.

Dispepsia: 2 D + P y alarma

- **D**olor · **D**istensión · **P**irosis (regla del profe).
- Alarma: **VIDA que PESA** → **VEDA**: Vómitos, Ictericia, Disfagia, Anemia · Pérdida de peso, Edad > 55, Sangrado, AINEs/Antecedentes → endoscopía.

Mnemotecnia: Una VIDA que PESA → VEDA — Mnemotecnia propia para los signos de alarma.

Errores que pueden aparecer en el examen

- Decir que la hematemesis es alcalina: en el cuadro del libro la **alcalina es la hemoptisis**.
- Confundir la tríada de **Mallory-Weiss** con la de **Murphy** (dolor, vómitos, fiebre).
- Llamar «de transferencia» a la disfagia esofágica: transferencia = **orofaríngea**.
- Decir que la disfagia motora es solo para líquidos: es para **sólidos y líquidos**.
- Asociar vómito bilioso al síndrome pilórico: con el píloro cerrado la bilis no llega al estómago.

Preguntas de repaso (choice)

1. Sangre roja rutilante y espumosa expulsada con la tos, de reacción alcalina, corresponde a:
    A. Melena.
    B. Epistaxis.
    C. Hematemesis.
    D. Hemoptisis.

2. Un vómito en **borra de café** indica:

   A. Sangre ya digerida por el ácido gástrico.
   B. Siempre hemoptisis deglutida.
   C. Origen colónico.
   D. Sangrado activo arterial.

3. Vómito de alimentos ingeridos varias horas antes, con chapoteo gástrico:

   A. Gastroenteritis.
   B. Hipertensión endocraneana.
   C. Embarazo.
   D. Síndrome pilórico.

4. Vómito matinal en ayunas. Las tres causas que remarca el profe son:

   A. Embarazo, alcohol la noche anterior e hipertensión endocraneana.
   B. Úlcera, gastritis y pancreatitis.
   C. Síndrome pilórico, íleo y apendicitis.
   D. Ménière, migraña y cinetosis.

5. Vómito en chorro, sin náuseas, con cefalea intensa: hay que pensar en

   A. Úlcera péptica.
   B. Hipertensión endocraneana.
   C. Gastroenteritis.
   D. Síndrome pilórico.

6. La tríada de Mallory-Weiss es:

   A. Disfagia, pérdida de peso y anemia.
   B. Dolor torácico, enfisema subcutáneo y vómitos.
   C. Dolor, vómitos y fiebre.
   D. Alcoholismo, vómitos y hematemesis.

7. Alteración esperable en un paciente con vómitos profusos:

   A. Acidosis respiratoria.
   B. Hipernatremia aislada.
   C. Alcalosis metabólica con hipopotasemia.
   D. Acidosis metabólica con hiperpotasemia.

8. ¿Qué diferencia a Mallory-Weiss de Boerhaave?

   A. Boerhaave no ocurre por vómitos.
   B. Mallory-Weiss: desgarro de la mucosa; Boerhaave: rotura de todo el espesor.
   C. Mallory-Weiss es transmural.
   D. Mallory-Weiss nunca sangra.

9. La disfagia orofaríngea también se llama:

   A. Globo histérico.
   B. Odinofagia.
   C. Alta o de transferencia.
   D. Baja o de transporte.

10. Disfagia esofágica **solo para sólidos**, continua y progresiva: orienta a
    A. Disfagia orofaríngea.
    B. Causa mecánica (obstructiva).
    C. Trastorno motor.
    D. Globo histérico.

11. Disfagia lentamente progresiva para sólidos y líquidos con regurgitación, en un paciente con Chagas:
    A. Acalasia.
    B. Estenosis péptica.
    C. Cáncer de esófago.
    D. Disfagia orofaríngea.

12. ¿Cuál es un signo de alarma en dispepsia?
    A. Eructos.
    B. Tener 30 años.
    C. Anemia.
    D. Pirosis ocasional.

13. Paciente alcohólico que tras vómitos repetidos presenta vómito con sangre. ¿Qué tríada cumple?
    A. Murphy.
    B. Charcot.
    C. Mallory-Weiss.
    D. Ninguna: es una hemoptisis.

14. Sangre oscura con restos alimentarios, precedida de náuseas, y melena al día siguiente:
    A. Hematemesis.
    B. Epistaxis.
    C. Gingivorragia.
    D. Hemoptisis.

15. “Las dos D y la P” de la dispepsia son:
    A. Distensión, disfonía, plenitud.
    B. Dolor, deshidratación, pérdida de peso.
    C. Dolor epigástrico, distensión, pirosis.
    D. Disfagia, diarrea, pirosis.

Respuestas

1. **D** — Correcto: viene de la vía aérea, con aire (espuma) y reacción alcalina.
2. **A** — Correcto: la hemoglobina se convirtió en hematina ácida.
3. **D** — Correcto: el estómago no vacía (vómito 4–6 h después).
4. **A** — Correcto.
5. **B** — Correcto.
6. **D** — Correcto (y es su cronología).
7. **C** — Correcto: pérdida de cloro (HCl) y potasio.
8. **B** — Correcto.

9. **C** — Correcto.
10. **B** — Correcto: un obstáculo deja pasar líquidos pero no sólidos.
11. **A** — Correcto: “lo que siempre suelen preguntar”.
12. **C** — Correcto: puede indicar cáncer o sangrado.
13. **C** — Correcto: alcoholismo, vómitos, hematemesis.
14. **A** — Correcto.
15. **C** — Correcto.